



التشخيص الإكلينيكي المتقدم

ورشة عمل لمتدربين مركز مطمئنة في علم النفس الإكلينيكي

محمد القحطاني

مركز مطمئنة



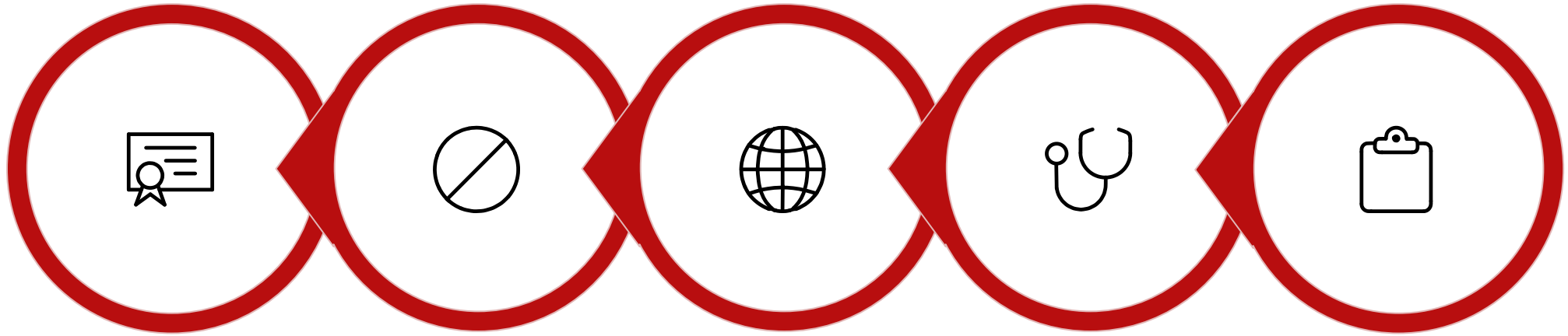


مقدمة: لماذا التشخيص أساس كل شيء؟

يُعدّ التشخيص الإكلينيكي من أرقى المهارات التي تميّز الأخصائي النفسي المحترف عن غيره. فهو لا يقتصر على مجرد تسمية الاضطراب أو إلصاق تصنيف بالحالة، بل يتجاوز ذلك إلى فهم الإنسان في كليّته: نفسيًا، وسلوكيًا، واجتماعيًا، ووظيفيًا.

كلما ارتفعت جودة التشخيص، ارتفعت معها فرص نجاح التدخل العلاجي، وانخفضت احتمالية الخطأ الإكلينيكي. التشخيص الدقيق هو البوصلة التي توجّه كل خطوة لاحقة في رحلة العلاج.

تعريف التشخيص الإكلينيكي



الوصول
للتشخيص

استبعاد
الأسباب

فهم السياق

تحليل الأعراض

جمع
المعلومات

التشخيص الإكلينيكي هو عملية علمية منظمة ومنهجية، تهدف إلى جمع المعلومات الشاملة، وتحليل الأعراض بعمق، وفهم السياق البيئي والنفسي، واستبعاد الأسباب العضوية والمادية، ثم الوصول إلى أقرب تفسير سريري وفق المعايير الدولية المعتمدة كـ DSM-5 و ICD-11.

أهمية التشخيص الدقيق

🎯 اختيار الخطة العلاجية

التشخيص الصحيح يقود إلى البروتوكول العلاجي الأنسب، سواء كان نفسيًا أو دوائيًا أو تكامليًا.

🛡️ تقليل الخطأ العلاجي

التشخيص الخاطئ قد يُفضي إلى تدخلات غير ملائمة تُضر بدلًا من أن تنفع.

🔍 فهم أعمق للحالة

يتيح رؤية المشكلة من أبعاد متعددة: النفسية والبيولوجية والاجتماعية.

📈 التنبؤ بمسار الحالة

معرفة التشخيص تساعد في توقع تطور الحالة وتحضير المريض وأسرته.

⚠️ تحديد مستوى الخطورة

يُمكن الأخصائي من تقييم خطر الأذى الذاتي أو الإيذاء بدقة.

📄 تحسين التقارير المهنية

التقارير المبنية على تشخيص دقيق أكثر مصداقية وفعّالة للفريق المتعدد التخصصات.

ماذا ليس التشخيص؟

ليس وصمة اجتماعية

التشخيص أداة فهم وليس حكمًا على الإنسان. الاضطراب لا يُعرّف الشخص ولا يُحدد قيمته.

ليس اختزالًا للإنسان في مرض

الإنسان أعمق وأشمل من أي تصنيف تشخيصي. العلاقة الإنسانية مع المريض تسبق التصنيف.

لا يُبنى على عرض واحد

الأعراض المنفردة لا تكفي. لا بد من نمط متكامل، ومدة زمنية كافية، وتأثير وظيفي واضح.

لا يُبنى على الانطباع الأول

الانطباع الأول قد يكون مضللًا. التشخيص يحتاج إلى تقييم منهجي متأن عبر الزمن.

MMPI

Minnesota Multiphasic Personality Inventory

Personality Assessment
Clinical Edition

I feel nervous in social situations.	True ☐
I often worry about my health.	True ☐
I like a notheing wind mydeg bouk.	False ☐
I tude sijands?	False ☐
I Ger my tolufo?	False ☐
I heritly boing arorow otter visibly?	True ☐
I Fadly joo un anof doing?	True ☐
I enjoy ao whete to rah arly?	True ☐
Toudry hignisty heving sonubis to wrheaked?	True ☐
I whov cane munde one ineing?	True ☐
I Thity he foy mver mirthedong to your and?	True ☐
nenole?	True ☐
I endy hove sene yot ut whinjc boop?	True ☐
I ouia ne cont ou hathe?	True ☐
I eniny suigatuhs efy sanp?	True ☐
I enjoy being around other people.	True ☐

Personality Assessment

خطوات التشخيص المتقدم



الإصغاء السريري

الاستماع الفعّال إلى ما يُقال وما لا يُقال، وملاحظة اللغة الجسدية وطريقة السر.



جمع التاريخ المرضي

استيعاب التاريخ الشخصي والأسري والطبي والنفسي للحالة بشكل شامل.



استخراج الأعراض

تحديد الأعراض الأساسية والثانوية، وترتيبها وفق المعايير التشخيصية المعتمدة.



فهم البداية والمسار

متى بدأت الأعراض؟ هل تتصاعد أم تتراجع؟ هل ثمة محفزات واضحة؟



تقييم الأداء الوظيفي

قياس تأثير الأعراض على العمل والعلاقات والحياة اليومية.



استبعاد الطبي والمواد

التحقق من الأسباب العضوية والدوائية وتأثير المواد المخدرة قبل الحكم النفسي.



الوصول للتشخيص الأقرب

اختيار التشخيص الأكثر توافقًا مع مجموع الأدلة المتاحة مع الإبقاء على مرونة المراجعة.



بناء التشخيصات الفارقة

وضع قائمة بالتشخيصات المحتملة ومقارنتها منهجيًا بناءً على الأدلة.

التشخيصات الفارقة: الأزواج الأكثر إرباكًا

التشخيص الفارق هو قدرة الأخصائي على التمييز بدقة بين اضطرابات تتشابه في مظهرها الخارجي لكن تختلف في جوهرها وعلاجها.

أوجه التشابه	أوجه الاختلاف الرئيسية	الزوج التشخيصي (الاضطراب الأول / الاضطراب الثاني)
مزاج منخفض، فقدان الطاقة، اضطراب النوم	ثنائي القطب يشمل نوبات هيبومانيا أو مانيا، بينما الاكتئاب لا يشمل ارتفاع المزاج	الاكتئاب الكبير / ثنائي القطب
قلق مستمر، أفكار متكررة، توتر	الوسواس يشمل أفكارًا تدخلية لا إرادية وطقوسًا قهرية، بينما القلق العام يدور حول مخاوف يومية واقعية	القلق العام / الوسواس القهري
تقلب المزاج، اندفاعية، علاقات متوترة	تقلب الحدية مرتبط بالعلاقات ومستمر، بينما نوبات ثنائي القطب أطول وأكثر استقلالية عن المحفزات	الشخصية الحدية / ثنائي القطب
الاهتمام بالتفاصيل، الحاجة للنظام، الكمالية	الوسواس القهري يسبب ضيقًا وأفكارًا تدخلية، بينما الشخصية الوسواسية نمط ثابت من الصرامة دون ضيق واضح	الوسواس القهري / اضطراب الشخصية الوسواسية
أعراض جسدية حادة (ضيق، خفقان، دوار)	الهلع لا يُفسّر طبيًا ومرتبطة بالخوف من الخوف، بينما الأسباب الطبية لها تفسير عضوي واضح	اضطراب الهلع / أسباب طبية
الشعور بالغرابة، انفصال عن الواقع	تبدد الواقع يحتفظ فيه الشخص بالاستبصار ويعرف أن ما يحدث غير طبيعي، بينما الذهان يفقد فيه الشخص الاستبصار ويؤمن بالتجربة	تبدد الواقع / الذهان

التشخيصات الفارقة: أزواج إضافية

استكمالاً للأزواج السابقة، إليك مزيداً من الاضطرابات المتشابهة التي تستوجب تمييزاً دقيقاً.

أوجه التشابه	أوجه الاختلاف الرئيسية	الزوج التشخيصي (الاضطراب الأول / الاضطراب الثاني)
مزاج منخفض، عزلة اجتماعية، اضطراب النوم، فقدان الاهتمام	مرتبط بحدث صادم محدد ويشمل ذكريات PTSD اقتحامية وتجنباً واستثارة مفرطة، بينما الاكتئاب لا يشترط وجود صدمة	اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) / الاكتئاب الكبير
خوف من الحكم الاجتماعي، تجنب المواقف الاجتماعية، خلل شديد	القلق الاجتماعي اضطراب قلق محدد بمواقف الأداء والتفاعل، بينما الشخصية التجنبية نمط شخصية عميق وشامل يمتد لكل جوانب الحياة	اضطراب القلق الاجتماعي / الشخصية التجنبية
هلوسات، أوهام، تفكير مشوش	الاضطراب الفصامي العاطفي يشمل نوبات مزاجية واضحة (اكتئاب أو هوس) متزامنة مع الأعراض الذهانية، بينما الفصام لا تكون فيه الأعراض المزاجية محورية	الفصام / الاضطراب الفصامي العاطفي
قلق مستمر، توتر، صعوبة تركيز، اضطراب نوم	يشمل ذكريات اقتحامية وكوابيس وتجنباً مرتبطاً PTSD بالصدمة، بينما القلق العام قلق منتشر غير مرتبط بحدث بعينه	اضطراب القلق العام / اضطراب ما بعد الصدمة
أوهام، هلوسات، انسحاب اجتماعي	في الاكتئاب الذهاني تكون الأعراض الذهانية مصاحبة لنوبة اكتئاب حادة وتزول معها، بينما في الفصام الأعراض الذهانية مستقلة ومستمرة	الاكتئاب الذهاني / الفصام
أعراض جسدية بدون تفسير طبي عضوي، ضيق نفسي	اضطراب التحول يظهر كأعراض عصبية محددة (شلل، عمى، نوبات)، بينما الاضطراب الجسدي الوظيفي يشمل آلاماً وأعراضاً جسدية متعددة ومتنوعة	اضطراب التحول (Conversion) / الاضطراب الجسدي الوظيفي

أخطاء تشخيصية شائعة

الأخطاء التقييمية

- تجاهل الاضطرابات المصاحبة (Comorbidities) وعزل الحالة
- الخلط بين سمات الشخصية والاضطراب النفسي الفعلي
- إسقاط التوقعات الثقافية على تفسير الأعراض
- عدم المراجعة الدورية للتشخيص الأولي مع تطور الحالة

الأخطاء المنهجية

- التسرع في الوصول إلى تشخيص قبل استيفاء المعلومات
- الاعتماد على الانطباع الأول وتجاهل ما يتناقض معه
- تجاهل معيار المدة الزمنية اللازمة للتشخيص
- إغفال دور المواد والأدوية في توليد الأعراض



مهارة الإصغاء السريري: ترجمة القصة إلى أعراض

العميل لا يقول: «لديّ رهاب ساحة» — بل يقول: «أبحث دائمًا عن أقرب باب»
العميل لا يقول: «لديّ اندفاعية» — بل يقول: «أفعل أشياء وأندم عليها بعدها»

دور الأخصائي النفسي ليس انتظار الإجابات الجاهزة، بل ترجمة لغة المعاناة اليومية إلى مصطلحات سريرية دقيقة. الإصغاء السريري يعني الاستماع إلى ما وراء الكلمات: الصمت، والتردد، وطريقة وصف المشاعر، وما يتجنب العميل ذكره.



الأخصائي المتقدم يسمع الرواية كاملةً قبل أن يفكر في التصنيف — القصة هي البيانات الأولى وأصدقها.

الحالات التطبيقية

في الجزء التالي، ستعرض ثمانى حالات إكلينيكية حقيقية بأسلوب السرد الأول الشخصي — كما تُعبّر المريضة عن نفسها بالفعل. وبعد كل حالة، يأتي التحليل التشخيصي المنهجي.

التنوع

ثمانى حالات تغطي مجالات تشخيصية مختلفة: مزاجية، قلقية، شخصية، ذهانية

المنهجية

قراءة السرد → استخراج الأعراض → بناء التشخيص الفارق → الوصول للأقرب

الهدف

تطبيق خطوات التشخيص المتقدم على حالات حية متنوعة

بشاير — بكلماتها

«أنا تعبت من كلمة إنك متقلبة. الناس يشوفون النتيجة وما يشوفون وش يصير داخلي. أحيانًا أمر بفترات أحس فيها الدنيا أخيرًا فتحت لي بابها، أقوم بدري بدون منبه، أخلص شغلتي متراكمة من شهور، أتصل على ناس انقطعت عنهم، أفكر بمشروع جديد... حتى كلامي يصير كثير وأمي تقول: اهدي شوي. بعدها فجأة كأن أحد سحب الفيش. أبدأ أتأخر، أتجنب الردود، أبكي من أشياء تافهة وأحس أنني حمل على أهلي. أكثر شيء يوجعني إنني وقت النشاط أصدق أنني تعافيت، وبعدها أرجع لنفس الحفرة.»

تشخيص بشاير: ثنائي القطب النوع الثاني

التشخيص والتمييز

التشخيص الأقرب: اضطراب ثنائي القطب النوع الثاني

يتميز عن النوع الأول بغياب نوبات الهوس الكامل (Mania). الهيبومانيا أقل حدةً لكنها واضحة. يجب استبعاد: الاكتئاب الأحادي القطب مع تقلب مزاجي، واضطراب شخصية حدية.

✓ مفتاح التشخيص: التناوب الزمني المتكرر + ضعف الاستبصار في مرحلة الارتفاع.

الأعراض المستخرجة

- نوبات طاقة مرتفعة مع قلة الحاجة للنوم (هيبومانيا)
- تسارع التفكير وكثرة الكلام والتخطيط المفرط
- نوبات اكتئابية واضحة: بكاء، انسحاب، إحساس بالعبء
- التناوب بين الحالتين مع فترات وظيفية طبيعية

دانة — بكلماتها

«من وأنا صغيرة يقولون عني ذكية لكن مشتتة. كنت أنجح آخر لحظة. الحين بالماجستير صار الوضع محرج. أفتح الملف وأجلس أرتب المكتب، أرد على رسائل، أجيب قهوة، أشيك بريدي، أبحث عن شيء مو مهم، وفجأة يروح الوقت. إذا قرب التسليم أدخل بحالة ذعر، أسهر ليلة كاملة وأخلص الشيء بطريقة جيدة، ثم أرجع أكرر نفس الدائرة. أهلي يشوفونني مهملة، وأنا داخلي أحس أنني أحاول لكن ما أعرف أبداً من وين.»

تشخيص دالة: اضطراب ADHD لدى البالغين

التشخيص والتمييز

التشخيص الأقرب: اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD) لدى البالغين — النمط الغالب عليه عدم الانتباه

يجب استبعاد: القلق العام الذي يُقيّد البدء، والاكتئاب الذي يُسبب فقدان الدافعية. المفتاح هنا: التاريخ الطويل منذ الصغر.

ⓘ عند البالغين يُخطأ تشخيصه كثيرًا لأن الأعراض تبدو كسلًا أو ADHD. تسويّفًا لا اضطرابًا.

الأعراض المستخرجة

- صعوبة بدء المهام رغم وجود النية (تأخر التنفيذ)
- التشتت السهل في البيئات غير المهيكلية
- الأداء الممتاز تحت الضغط والمواعيد النهائية
- التاريخ المزمن منذ الطفولة

شاهد — بكلماتها

«صار عندي تفاوض يومي مع نفسي قبل ما أطلع. إذا كان المكان بعيد أفكر: لو تعبت هناك؟ وإذا زحمة أفكر: لو ما قدرت أطلع بسرعة؟ الناس يظنون أنني أحب البيت، لكن الحقيقة أنني أشتاق أطلع مثل أول. أكثر شيء يخوفني مو المكان نفسه، الخوف من الشيء اللي ممكن يصير لي وأنا فيه. مرة كنت في سوبرماركت وحسيت الدنيا ضاقت، صدري انشد، رجولي رخوة، وصرت أمشي بسرعة أدور الباب. من بعدها صرت أحسب حساب المخرج بأي مكان.»

تشخيص شهود: اضطراب الهلع مع رهاب الساحة

التشخيص والتمييز

التشخيص الأقرب: اضطراب الهلع مع رهاب الساحة (+ Panic Disorder Agoraphobia)

يجب استبعاد: الأسباب الطبية كاضطرابات القلب والغدة الدرقية، وفرط التنفس. التمييز الجوهرى: الخوف من الشعور لا من المكان.

✓ النقطة المحورية: شهود لا تخاف من السوبرماركت — تخاف مما قد تشعر به داخله.

الأعراض المستخرجة

- نوبة هلع سابقة مع أعراض جسدية حادة (ضيق، رقاوة، ضغط صدر)
- خوف توقعي من تكرار النوبة في أماكن لا يمكن الهروب منها
- سلوك تجنبى متطور (حساب المخرج، تجنب الأماكن المزدحمة)
- تراجع الجودة الوظيفية والاجتماعية

هيفاء — بكلماتها

«إذا سألتيني هل أعرف أني أبالغ؟ أقول نعم، لكن المعرفة ما تفيد. قبل ما أنام لازم ألف البيت وأشييك الأبواب والغاز والنوافذ. أحيانًا أرجع لنفس المكان أكثر من مرة، مو لأنني نسيت، لكن لأنني ما وثقت بإحساسي أول مرة. زوجي يقول الباب مقفل وأنا أصدقه، لكن بعد دقائق أحتاج أتأكد بنفسي. أكثر شيء يتعبني مو الوقت، الإحساس بالمسؤولية. كآني لو تجاهلت الفكرة وصار شيء، يكون كله بسببي.»

تشخيص هيفاء: وسواس قهري مع ضعف استبصار جزئي

التشخيص والتمييز

التشخيص الأقرب: اضطراب وسواس قهري (OCD) مع ضعف استبصار جزئي
يتميز عن القلق العام بوجود الطقوس والأفكار التسللية المحددة. يتميز عن الشخصية الوسواسية بالمعاناة والتطفلية.

⚠️ التطمين المتكرر من الآخرين يُغذي الدورة الوسواسية ولا يكسرها
— معلومة جوهرية لتوجيه الأسرة.

الأعراض المستخرجة

- أفكار وسواسية حول الخطر والمسؤولية (Obsessions)
- طقوس تحقق متكررة لا تُخفف القلق بصورة دائمة (Compulsions)
- استبصار جزئي: تعرف المبالغة لكن لا تستطيع إيقافها
- فشل التطمين الخارجي في إيقاف الدورة

ريم — بكلماتها

«أنا أحب بصدق، لكن ما أحد يتحملني. إذا قربت من أحد يصير هو عالمي. وإذا حسيت بتغير بسيط، حتى لو مجرد تأخير رد، يتبدل يومي كامل. مرة أقول خلاص ما أبيه، ومرة أترجاه ما يتركني. بعد كل مشكلة أكره نفسي وأقول أنا السبب. أحيانًا أسوي أشياء وأنا معصبة وأندم بعدها: شراء، قيادة بسرعة، كلام جارح. وفي فترات أخرى أحسني فوق كل هذا، أطلع كثير، أتعرف على ناس، أنام ساعات قليلة وأقول أخيرًا صرت قوية.»

تشخيص ريم: شخصية حدية مع استبعاد ثنائي القطب

التشخيص والتمييز

التشخيص الأقرب: اضطراب شخصية حدية (BPD)

التمييز عن ثنائي القطب: في BPD التقلب مزاجي مرتبط بالعلاقات وسريع (ساعات)، أما في ثنائي القطب فالدورات أطول وأكثر استقلالية عن المحيط.

⚠️ الجمع بين الاثنين ممكن — استبعاد ثنائي القطب ضروري قبل الوصول للتشخيص النهائي.

الأعراض المستخرجة

- خوف شديد من الهجر يتحكم في العلاقات
- تقلب في تقييم الذات والآخرين (idealization/devaluation)
- اندفاعية في سياقات متعددة (قيادة، مشتريات، كلام)
- تقلب مزاجي مرتبط بالعلاقات لا بالدورات الزمنية

منى — بكلماتها

«أنا ما أحب أتكلم بالموضوع لأن الناس تفسر غلط. لكن صرت أحس أنني مكشوفة. إذا دخلت مكان وسكتوا فجأة يجي ببالي أنهم كانوا يتكلمون عني. وإذا ضحك اثنين جنب بعض أحاول أقنع نفسي أنه عادي، لكن داخلي يقول لا. أحيانًا وأنا بالبית أسمع شيء يشبه أحد ناداني، وأطلع ما ألقى أحد. نومي ملخبط، وأمر بضغط كبير، وأستخدم شيء يهديني بالليل لكن ما أشوفه مشكلة.»

تشخيص متى: اضطراب ذهاني ناشئ أو ذهان مستحث

التشخيص والتمييز

التشخيص الأقرب: اضطراب ذهاني ناشئ (Brief Psychotic Disorder) أو ذهان مستحث بالمواد

الأولوية التشخيصية هنا: استبعاد المواد أولاً. ثم تقييم الاستمرارية الزمنية للأعراض للتفريق بين الذهان الحاد والفصام المبكر.

⊗ يستوجب إحالة عاجلة لتقييم الطب النفسي. المواد قد تكون سبباً أو مُشعّلاً.

الأعراض المستخرجة

- هلوسات سمعية (نداء بدون مصدر)
- أفكار إسقاطية (الناس تتكلم عني، تضحك عليّ)
- إنكار المشكلة وضعف الاستبصار
- استخدام مواد تحت الضغط + اضطراب النوم

أفراح — بكلماتها

«أحيانًا إذا تراكم علي كل شيء يصير العالم غريب. أعرف أن هذا الشارع هو نفسه، وهذا بيتي، لكن أحسه نسخة منه. صوتي يصير بعيد، وإذا لمست يدي أحسها كأنها تخص أحد ثاني. أجلس أخاف وأسأل نفسي: هل بدأت أفقد عقلي؟ الغريب أنني أكون واعية بكل شيء، وأعرف أن الشعور هذا غريب، لكنه يكون قوي جدًا. إذا ارتحت أو نمت يخف.»

تشخيص أفراح: تبدد الواقع / تبدد الشخصية

التشخيص والتمييز

التشخيص الأقرب: اضطراب تبدد الواقع/تبدد الشخصية المرتبط بالقلق
التمييز عن الذهان: في الذهان يُفقد الاستبصار ويُصدّق بالتجربة. هنا أفراح
تعرف تمامًا أن ما تشعر به غير طبيعي.



الاستبصار المحفوظ هو الفارق الجوهرى بين تبدد الشخصية
والذهان — ولا يجب أبدًا الخلط بينهما.

الأعراض المستخرجة

- تبدد الشخصية (Depersonalization): الإحساس بالانفصال عن الجسد
- تبدد الواقع (Derealization): البيئة تبدو غير حقيقية
- الاستبصار الكامل محفوظ: تعرف أن الشعور غير طبيعي
- مرتبط بالضغط ويزول مع الراحة

أروى — بكلماتها

«أنا أحتاج الأشياء تمشي صح، وإذا ما مشت أتوتر. مو لأن الناس لازم تكون مثلي، لكن لأن الخطأ يعلق في رأسي. إذا سويت تقرير أراجعه مرات كثيرة، وإذا أرسلته أجلس أفكر هل نسيت كلمة أو فاصلة. الناس يشوفونني دقيقة، وأنا أشوف نفسي بطيئة. وفيه جانب ثاني ما يعرفه أحد، تجيني أفكار سخيفة ومقرزة جدًا، مو من طبعي أبدًا. وأظل أحاول ألغيها بأشياء معينة داخل عقلي.»

تشخيص أروى: وسواس قهري مع سمات شخصية وسواسية

التشخيص والتمييز

التشخيص الأقرب: اضطراب وسواس قهري (OCD) مع سمات شخصية وسواسية قهرية (OCPD)

الفارق الجوهرى بين OCD و OCPD: في OCD الأفكار تطفلية ومزعجة. في OCPD السمات الكمالية يُرى فيها الشخص أمرًا طبيعيًا ومرغوبًا.

الجمع بين الاثنين ممكن — كما في حالة أروى — ويستوجب خطة علاجية متكاملة.

الأعراض المستخرجة

- أفكار تدخلية مقلزة (Intrusive Thoughts) لا تتوافق مع الشخصية
- طقوس ذهنية للتحييد (Mental Compulsions)
- مراجعة مفرطة للأعمال + كمالية مُعيقة
- سمات شخصية وسواسية (OCPD) مصاحبة

خاتمة: ما الذي يبحث عنه الشخص الجيد؟

التشخيص ليس وجهة نهائية، بل نقطة انطلاق نحو فهم أعمق وتدخل أكثر دقة وإنسانية.



الأسباب

العوامل البيولوجية والنفسية والاجتماعية
المهنية والمشغلة



المسار

كيف تطورت الحالة منذ بدايتها حتى اليوم



النمط

كيف تتكرر الأعراض وما طابعها الزمني
والموقفي



أفضل تدخل علاجي

البروتوكول الأنسب مبنياً على التشخيص الدقيق والفهم الشامل



الخطورة

تقييم مستوى الأذى الذاتي أو للآخرين ومدى الإلحاح

الشخص الجيد لا يرى في العميل مرضاً يُحل، بل إنساناً يُفهم — والتشخيص الدقيق هو الطريق الأمين نحو ذلك الفهم.